

01 - 01- Fibromes Utérins - Pr. SOUMMANI

Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui les fibromes utérins. Ils sont également appelés fibromyomes utérins. Ce sont des tumeurs bénignes qui se développent au sein de muscles utérins.

C'est une prolifération dégénérative d'éléments fibro-conjonctives et de tissus musculaires lisses. C'est une pathologie qui est très fréquente. En général, après 35 ans, une femme sur 4 développera un fibrome utérin.

La symptomatologie est variable et peut être asymptomatique comme il peut engendrer des hémorragies parfois importantes entraînant une anémie. Le traitement peut être médical ou chirurgical ou peut ne pas avoir besoin. Les objectifs de ce chapitre sont les définitions, connaître l'épidémiologie et les différents types anatomopathologiques, l'étude clinique, les complications et les différents types de traitements.

Sur le plan épidémiologique, la fréquence des fibromes varie entre 20 et 40%, surtout chez la femme de peau blanche. Il y a presque 50% de cas chez les femmes de peau noire. La tranche d'âge la plus touchée est comprise entre 30 et 40 ans.

Le fibrome utérin est une pathologie de la femme en période d'activité génitale. Pour les femmes de peau noire, la survenue peut être à un âge plus jeune. Le terrain est un terrain d'hyperostrogénie.

C'est une condition nécessaire pour la croissance des fibromes. L'hyperostrogénie peut être absolue ou relative. Absolue signifie que le taux d'oestrogène dans le sang est élevé.

Relative signifie que le taux d'oestrogène est normal, mais l'effet biologique d'oestrogène est élevé. En général, il est dû à une insuffisance lutéale qui entraîne une diminution de la progestérone pendant la phase lutéale. Cette progestérone devrait contrecarrer.

L'effet délétère de l'oestrogène n'existe plus. Il y a un terrain particulier appelé terrain fibromateux. C'est l'association d'obésité, hypertension artérielle et dystrophie mammaire.

Sur le plan anatomopathologique, le fibrome utérin a une topographie particulière. L'utérus est constitué d'abord d'un corps utérin, puis d'un isthme et enfin d'un col utérin. Le fibrome peut siéger dans ses différentes parties de l'utérus, que ce soit au niveau du corps utérin, c'est le cas le plus fréquent, dans presque 95% des cas, il peut siéger au niveau du fond utérin, il peut siéger au niveau des deux faces de l'utérus, comme il peut siéger au niveau des cornes de l'utérus.

La localisation cervicale survient à 3-4% des cas, mais ici il y a un risque particulier de compression de l'urètre qui passe à proximité également au niveau du isthme. Par rapport aux différentes tuniques, on sait que l'utérus est constitué par une paroi musculaire, par une sous-

serreuse et par une sous-muqueuse. Le fibrome utérin peut affecter ces différents tuniques de l'utérus.

Les plus fréquents sont les fibromes interstitielles, appelés également fibromes corporeaux, ils surviennent au niveau de l'épaisseur du myomètre, mais ils peuvent être sous-serreux, c'est-à-dire à la surface de l'utérus, soit sessiles, soit attachées à l'utérus par un pédicule, et dans ce cas il est appelé fibrome sous-serreux pédiculé. Il peut survenir également au niveau de la sous-muqueuse, et ils vont faire saillir dans la cavité utérine, et dans ce cas le risque hémorragique est plus important. Voilà les différents types de fibromes.

Nous avons ici un fibrome sous-muqueux, un autre fibrome sous-muqueux intra, appelé intracavitaire, parce qu'il est développé à l'intérieur de la cavité de l'utérus. Ici c'est un fibrome interstitiel, et ici également c'est un fibrome sous-serreux sessile, il n'y a pas de pédicule, et ici c'est un fibrome sous-serreux pédiculé, un pédicule qui est large. Voilà les différentes localisations par rapport aux différents tuniques de l'utérus.

Il faut toujours garder à l'esprit que ces fibromes sous-muqueux sont les fibromes les plus hémorragiques. Sur le plan macroscopique, le fibrome utérin peut être unique ou multiple. Il est de taille variable allant de quelques millimètres jusqu'à trentaines à quarante centimètres de diamètre.

C'est une tumeur qui peut être ronde ou polylobée. La couleur est en général blanchâtre ou blanc-âcre, de consistance ferme. Il est limité par une pseudo-capsule.

Il n'y a pas de capsule réelle, mais une pseudo-capsule qui va limiter cette tumeur. Ici, il y a également différents types de fibromes. Là, un fibrome sous-serreux pédiculé, un fibrome intramural, interstitiel ou corporel.

Voilà l'un ici, voilà l'autre là. Ici, c'est un fibrome sous-serreux sessile. Ici, c'est un fibrome sous-muqueux.

Ici, c'est un fibrome sous-muqueux intracavitaire. Notez, encore une fois, que ces fibromes intracavitaires ou sous-muqueux sont les fibromes les plus hémorragiques. Voilà ici, également, sur une pièce d'une hystérectomie totale.

Ça, c'est le col de l'utérus. Ça, c'est l'isthme. Et ça, c'est le corps de l'utérus.

On voit très bien un fibrome ici. Regardez, un fibrome avec un aspect blanchâtre. C'est un peu tumorent.

Et ici, également, un tout petit fibrome qui est sous-muqueux. Et on voit ici une lésion au niveau de la muqueuse. Il faut faire attention parce que le fibrome, surtout chez la femme avant la ménopause, peut avoir un cancer de l'endomètre associé.

La vascularisation du fibrome est une vascularisation précaire. C'est-à-dire, il n'est vascularisé que par un fin réseau artériolaire superficiel, ce qui explique les complications fréquentes des fibromes, soit l'ischémie du fibrome, soit une hémorragie par rupture du réseau lors d'une torsion du fibrome, et il peut être également un point de départ de complications thromboemboliques post-opératoires. Sur le plan anatomopathologique microscopique, le fibrome utérin est caractérisé par l'existence d'une juxtaposition de deux tissus en proportion très variable, un tissu myomateux qui a un aspect en tourbillon caractéristique des fibres musculaires lisses et un tissu fibreux comportant des cellules fusiformes.

Il faut noter également qu'il y a la possibilité de l'existence d'une lésion associée qui aura un pronostic plus mauvais que le fibrome, telle qu'une hyperplasie de la muqueuse de l'utérus de l'endomètre, un polype, une endométriose ou carrément un cancer endométrial. Sur le plan clinique, le maître symptôme des fibromes utérins est l'hémorragie, c'est-à-dire des règles, une menstruation qui est augmentée en volume et en durée. En général, les règles, c'est entre 3 à 4 jours, ça peut aller dans le cas des fibromes jusqu'à 8 à 10 jours et également l'abondance des règles, c'est-à-dire de la menstruation, qui peut même entraîner une anémie.

C'est le signe le plus fréquent, c'est le signe le plus évocateur, mais sa durée et son abondance sont variables en fonction des femmes. Il peut également s'agir des métrorragies qui peuvent accompagner les ménorragies et dans ce cas, on parle de ménométrorragies et il faut faire attention, il faut chercher une lésion associée parce que les fibromes, en dehors des fibromes intracavitaires ou sous-muqueux, on traîne rarement des métrorragies, le plus souvent, c'est des ménorragies. Il peut s'agir de douleurs pelviennes telles que la pesanteur, puisque les fibromes sont grandes, ils peuvent aller jusqu'à 1 kg, 1,5 kg et par conséquent, la femme va sentir de la pesanteur, mais lorsque les douleurs sont aiguës, il faut craindre une complication.

Il peut s'agir d'hydrorée, c'est-à-dire des pertes liquidiennes, de mauvaise odeur, une masse abdominopelvienne également, c'est-à-dire une masse prenante tout l'abdomen qu'on peut palper à travers la paroi abdominale. Si les fibromes sont antérieures, en général, ils peuvent comprimer la vessie et dans ce cas, on va voir soit une pollacurie, soit une disurie. Comme ils peuvent être postérieurs, comprimant le rectum, et dans ce cas, on va avoir des troubles digestifs.

Parfois, les fibromes ne sont déclarées que lorsqu'il y a la survenue d'une complication, puisque 30 à 40 % des fibromes sont asymptomatiques, ils sont découverts lors d'un examen systématique. L'examen physique, à l'inspection, si le fibrome est grand ou si l'utérus est porteur de plusieurs fibromes, on va trouver une voussure de l'abdomen, l'abdomen qui va augmenter de volume, et la femme va consulter pour ça. La palpation, c'est une masse abdominale qui est régulière, qui est ferme, parfois élastique, et qui est mobile, c'est-à-dire qu'elle balote entre les deux mains.

C'est en milieu du spéculum, le saignement provient de l'intérieur de l'utérus s'il y a un

saignement, et c'est un moment propice pour faire un frottis cervico-vaginal de dépistage. Le toucher vaginal est un temps essentiel dans l'examen physique, de la patiente. Deux doigts de la main droite pour les droitiers en intravaginal, la main gauche doit prendre le fond de l'utérus, et en général, on va trouver une masse plus ou moins régulière, arrondie ou oblongue, comportant plusieurs nodosités, elle est ferme, toujours indolore, sauf s'il y a une complication, surtout la nécrobiose aseptique ou septique.

Il peut être limité au sein du pelvis, comme il peut déborder largement dans la cavité abdominale. Un point essentiel, c'est qu'en dehors des fibromes sous serreux pédiculés, le fibrome, en général, c'est une tumeur qui est solidaire avec l'utérus, c'est-à-dire qu'on ne va pas trouver de sillon de séparation entre la tumeur et l'utérus, et les mouvements imprimés à la masse ne sont pas ressentis par les doigts intravaginaux. Les examens complémentaires, surtout l'échographie pelvienne, en gynécologie, l'échographie pelvienne, c'est une continuation de l'examen physique, donc il est systématique lorsque l'on suspecte un fibrome utérin, il va faire le diagnostic en montrant une image éogène, homogène.

S'il y a une complication, ça peut être une image hétérogène, parce que dans la nécrose il y a du liquide, et par conséquent on aura une image hétérogène. Mais c'est surtout l'apport de l'échographie pelvienne, c'est l'étude de la taille, est-ce qu'il est de petite taille, est-ce qu'il est augmenté de volume, le nombre de fibromes, il peut aller de 1 jusqu'à une vingtaine ou même plus de fibromes, et la situation de fibromes par rapport aux différentes tuniques de l'utérus, surtout par rapport à la cavité utérine, et il permet d'éliminer les tumeurs d'autres origines, telles que les tumeurs anexielles, à savoir les tumeurs ovariennes, qui sont de pronostics plus serrés. Voilà ici on a une image d'un fibrome utérin, donc on voit ici l'utérus, c'est une échographie endovaginale, voilà l'utérus, le voilà, voilà la ligne de vacuité, on appelle la ligne de vacuité, c'est-à-dire la cavité utérine, l'endomètre, et voilà notre fibrome, il est là, c'est un aspect éogène, c'est-à-dire pratiquement le même aspect que la paroi utérine, et ici il est un peu hétérogène, peut-être qu'il y a un peu de nécrose.

Ici également, il y a un fibrome ici, le voilà, on va voir ici, voilà le fibrome, il est hétérogène, et ici il est associé à un sac gestationnel, une grossesse avec un nombrillon ici, donc ça c'est l'aspect d'un fibrome intramural ou interstitiel associé à une grossesse. Bon, on n'a pas toujours besoin d'une IRM, sauf dans quelques cas où on a une difficulté de diagnostiquer le fibrome, sinon on n'a pas, il n'est d'aucune utilité dans le diagnostic du fibrome, si l'échographie peut faire l'affaire, mais parfois il y a une suspicion de tumeur ovarien, surtout dans les fibromes sous-serreux pédiculés, on ne peut pas faire la part des choses entre une tumeur ovarien solide et un fibrome utérin, c'est là l'apport de l'IRM dans le diagnostic du fibrome utérin, ici c'est un utérus polymyomateux, on voit là les fibromes de l'utérus, ici c'est l'amycise, ici c'est le rectum, et bien sûr le racisme, vous le connaissez. En général, il est demandé, lorsque vous suspectez un fibrome calcifié, l'hystérosalpingographie n'a d'intérêt que lorsque dans un bilan d'infertilité de couple, l'hystérocopie, c'est-à-dire examiner la cavité de l'utérus par un matériel optique, en

général il est indiqué dans les fibromes intracavitaires ou sous-muqueux, c'est à la fois pour diagnostiquer le fibrome, mais également pour l'opérer.

La tomodensitométrie, et comme je vous ai dit, l'imagerie par résonance magnétique, ne se déplace que s'il y a un problème de diagnostic, surtout si on ne peut pas faire la part des choses entre un fibrome sous-serreux pédiculé et une tumeur ovarienne, on peut aller jusqu'à faire une celluloscopie pour voir si c'est un fibrome ou une tumeur anxielle, parfois on fait appel à l'échographie rénale lorsqu'on suspecte une compression de l'urtère qui va diagnostiquer une urithérohydronephrose. Les complications les plus fréquentes sont les complications hémorragiques, les complications hémorragiques soient des ménorragies de grande abondance, de moyenne abondance et de durée importante qui vont entraîner une anémie parfois sévère. L'hémorragie est surtout l'apanage des fibromes sous-muqueux, je répète encore une fois que les fibromes sous-muqueux sont les fibromes les plus hémorragiques.

Les complications douloureuses c'est également, à part la pesanteur, les autres douleurs aiguës, c'est en général lorsqu'il y a une complication mécanique, à savoir une torsion du fibrome, c'est-à-dire le fibrome qui va se tordre autour de lui-même et qui va entraîner une écrose, ça entraîne de la douleur. Les compressions, surtout de la vessie, du rectum, très très rarement des vaisseaux et des nerfs. Les complications par transformation histologique, il peut s'agir d'une necromyose aseptique, c'est-à-dire une écrose du fibrome parce qu'il est mal vascularisé, ce qui va entraîner une ischémie qui va engendrer de la douleur aiguë, un saignement noirâtre et une fibricule en général 38-35.

Il peut s'agir des complications de type de calcification, c'est les fibromes anciens, en général on les trouve chez les femmes âgées après la période d'activité génitale, c'est des fibromes qui ont séjourné pendant longtemps à l'intérieur dans la cavité de l'abdomen. Il peut s'agir des complications oedémateuses, également c'est de la nécrose. La transformation sarcomateuse, c'est-à-dire est-ce que le fibrome se transforme en sarcome ? C'est incertain, personnellement je dirais qu'il n'y a pas de transformation sarcomateuse, sauf s'il y a évolution des deux, fibrome et sarcome en même temps, ou bien s'il y a un problème au niveau de la lecture de la lame des fibromes.

Ici on voit des calcifications, un fibrome calcifié, on voit la calcification autour du fibrome. Ici c'est la ligne de vacuité, et ça c'est l'utérus. Ici c'est un stérilet, le voilà, avec des calcifications ici.

C'est un fibrome associé à un stérilet, c'est un stérilet en cuivre, et ici c'est les calcifications d'un fibrome très ancien, c'est un sous-serreux qui est calcifié. L'association fibrome et grossesse. En général toutes les complications gravidiques peuvent survenir au cours de l'existence d'un fibrome.

Ces complications gravidiques peuvent aller de la conception jusqu'aux suites de couches, à savoir l'infertilité, les fausses couches, l'accouchement prématuré, le placenta prévia, la dystocie

dynamique et mécanique, les hémorragies de la délivrance et la nécrobiose septique, c'est-à-dire une infection du fibrome. Bon, tous ces chapitres vont être étudiés, donc on ne va pas les aborder aujourd'hui. Chapitre thérapeutique, d'abord les moyens thérapeutiques.

Il faut dire que le fibrome utérin est une tumeur bénigne, le plus souvent asymptomatique, donc parmi les moyens thérapeutiques c'est l'abstention, ne rien faire lorsque c'est un petit fibrome, lorsque c'est un fibrome qui est asymptomatique. Le traitement médical, on a les progestatifs de synthèse, à savoir les plus utilisés sont les norgestrelanes, ils sont utilisés du 6^e au 25^e jour du cycle, ou du 16^e au 25^e jour du cycle, ou au 11^e au 25^e jour du cycle. On peut utiliser également les agonistes LH-RH, mais là ce sont, c'est une véritable ménopause thérapeutique, donc il ne faut pas dépasser 6 mois de traitement, sinon on va tomber dans les complications de la ménopause, à savoir les problèmes osseux, les problèmes cardiovasculaires, etc.

Si la femme est anémique, il faut donner du fer, si la femme a des douleurs, il faut donner un anti-inflammatoire. La chirurgie peut se faire soit par stéréoscopie, soit par la parotomie, soit par une hystéroscopie, ou par voie vaginale. Qu'est-ce qu'il faut faire ? D'abord il faut enlever les myomes, c'est la myomectomie, ou bien il faut enlever tout l'utérus, c'est l'hystérectomie.

Il ne faut pas oublier qu'il y a actuellement l'embolisation, c'est une technique radiologique, c'est-à-dire emboliser les vaisseaux utérins pour diminuer l'hémorragie du fibrome. Quelles sont les indications du traitement ? La règle, c'est l'abstention pour tous les fibromes de petits volumes, asymptomatiques et non compliqués. Pour les fibromes symptomatiques, qui ne sont pas une indication chirurgicale, dans ce cas vous traitez médicalement les patients.

Lorsqu'il y a une indication chirurgicale, à savoir le volume du fibrome supérieur ou égal à 10 cm, lorsque la femme présente une ménorragie et malgré la prise de traitement médical, elle continue à faire cette ménorragie, on l'appelle ménorragie rebelle au traitement, dans ce cas il faut l'opérer, les fibromes sous muqueux sont des fibromes qui sont rebelles au traitement médical, donc il faut les opérer, et dans ce cas c'est l'intérêt de l'hystéroscopie. Il faut opérer également les fibromes compressibles, surtout urinaires ou digestives, et il faut opérer les fibromes sous serreux avec nécrobiose aseptique ou tortue. Donc je répète, les indications de traitement chirurgicales sont le volume supérieur ou égal à 10 cm, les ménorragies rebelles au traitement médical, en général on donne un traitement pendant 3 à 6 mois, et si la femme continue à faire des ménorragies, dans ce cas il faut l'opérer.

Pour les fibromes sous muqueux, il faut les opérer, en général c'est par hystéroscopie, il faut opérer les femmes porteuses d'un fibrome compressif et les fibromes sous serreux en nécrobiose ou tortue. Qu'est-ce qu'il faut faire, quel type de traitement ? Si la femme est jeune, la femme désireuse de grossesse, dans ce cas il faut faire une myomectomie. Le nombre des fibromes, le volume des fibromes ne constitue pas une indication à l'hystérectomie.

Seule le cas où la femme n'est pas désireuse de grossesse, ou la femme qui présente un fibrome

associé à une autre pathologie utérine, dans ce cas on fait une hystérectomie, c'est-à-dire enlever tout l'utérus, et dans ce cas ça va être une hystérectomie inter-annexielle, c'est-à-dire il faut laisser les ovaires en place. En conclusion, le fibrome utérin est une pathologie très fréquente, je vous ai dit qu'une femme sur 4 après 36 ans présente un fibrome, il est rarement symptomatique et par conséquent le traitement n'est jamais systématique. Je vous remercie.